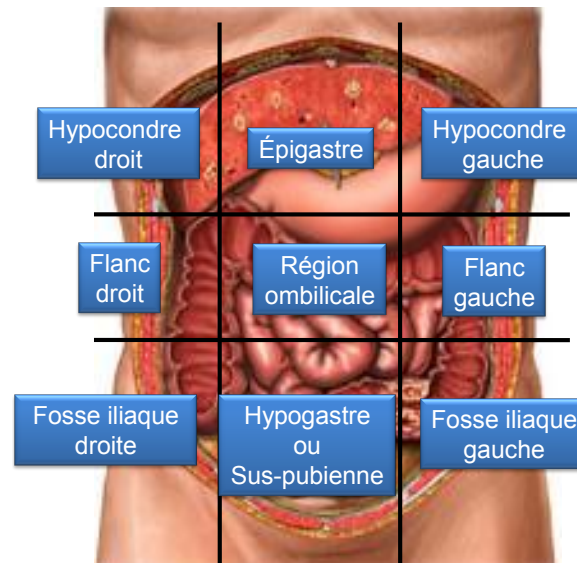


Examen de l'abdomen

Introduction

Il y a beaucoup d'organe dans la cavité abdominale. Le foie, premièrement, est bien caché derrière la cage thoracique et est difficile à palper. La rate n'est pas physiologiquement palpable, tout comme les reins qui se trouve à l'arrière de la cavité entre les 11^e et 12^e côtes.

On peut diviser l'abdomen en 4 quadrants, dont on se sert pour l'examen (supérieur, inférieur, droit, gauche), mais pour localiser précisément une anomalie perçue durant un tel examen on a une division en 9 quadrants.



Conditions générales et positionnement du patient

Il faut un bon éclairage, et le patient doit être détendu. L'abdomen est complètement mis à nu, et l'on dégage également les régions inguinales en faisant ouvrir la ceinture et en ouvrant un bouton. Les mains de l'examineur doivent être chaudes, et ses ongles courts. La vessie du patient doit être vide.

Le patient doit être couché confortablement sur le dos, avec un coussins sous la tête ou sous les genoux, et les bras le long du corps. Il est important d'expliquer et de prévenir le patient de toutes les manipulations.

Observer

Comme dans tout examen clinique, on commence par une phase d'observation. On observe le **visage** pour y détecter des signes de malaise, de douleur ou une respiration anormale, la **peau** pour mettre en évidence d'éventuelles vergetures, cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, etc., l'**ombilic** (localisation, aspect, couleur), l'**allure de l'abdomen** (symétrie, plat/arrondi), ainsi que les **mouvements** respiratoires, péristaltiques et pulsatiles.

Auscultation

Tout d'abord, avant l'examen proprement dit, demander au patient s'il a une douleur quelque part, et d'indiquer la zone douloureuse; l'examen devra toujours se terminer par la zone douloureuse.

L'examen abdominal, une fois n'est pas coutume, se TERMINE PAR LA PALPATION; celle-ci peut en effet perturber le système digestif, et ce n'est plus le système digestif « normal » que l'on examine ensuite.

On ausculte les 4 quadrants avec la membrane, sans trop appuyer. Si l'on n'entend rien, on peut provoquer des bruits en exerçant de légères pressions sur l'abdomen. Il faut décrire les bruits en fonction de deux paramètres: la qualité et la quantité. La tonalité normale est des gargouillis, et la fréquence normale est comprise entre 5 et 34/min (rester 30 secondes au même endroit si on entend rien).

Il ne faut pas oublier de terminer l'auscultation par l'**auscultation de l'aorte** (les autres vaisseaux sont trop difficiles); on l'entend bien en région péri-ombilicale droite. On doit entendre un léger souffle.

Percussion

Premièrement, délimiter la taille du foie, en distinguant le tympanisme des poumons de la matité du foie; il faut en faire le tour, même sur le flan. Tenter également de délimiter la rate, ce qui physiologiquement ne devrait pas être possible (peut permettre de suspecter une splénomégalie).

Ensuite, vérifier la distribution des gaz abdominaux en percutant un peu partout sur l'abdomen. Pour vérifier s'il y a du liquide, faire se tourner le patient sur le côté.

Palpation

En cas de résistance lors de la palpation, tenter de le détendre, relâcher le muscle grand droit par une expiration, ou demander au patient de respirer par la bouche, mâchoire tombante.

On commence par une **palpation superficielle**, avec une seule main, des 4 quadrants. Celle-ci aide à relever la résistance musculaire, identifie les structures superficielles et d'éventuelles masses, et sert à identifier les points douloureux. Il faut observer la tête du patient pour savoir si le contact est douloureux ou non.

Ensuite, on passe à la **palpation profonde** à deux mains, l'une sur l'autre, permettant l'exploration des 4 quadrants avec la pulpe des doigts. Pour toute masse, il faut préciser la localisation, la forme, la taille, la surface, le contour, la consistance, la mobilité et la sensibilité.

Ensuite, on peut également rechercher plusieurs signes pathologiques:

La recherche de **péritonisme** nécessite une palpation légère avec un doigt pour la localisation exacte; il faut rechercher une douleur brusque à la détente (décompression).

Le point de **Mc Burney** se trouve au tiers inférieur de la ligne entre l'ombilic et la crête iliaque; si la pression à cet endroit est douloureuse, cela suggère une appendicite.

Ensuite, on palpe les organes. On commence par le foie. On peut comprimer de la main gauche à l'arrière si on ne le sent pas, et dire au patient d'inspirer. Si l'on ne sent toujours pas le foie, on peut adopter la **technique du crochet** (patient obèse). Attention, la main qui tâte doit être en dehors du grand droit. Le signe de Murphy, indicateur d'une cholecystite, est lorsque cette palpation est douloureuse.



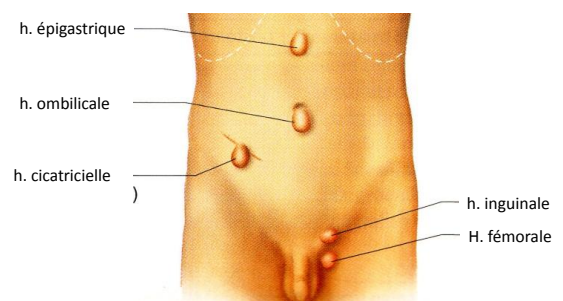
Pour la rate, la main gauche est dessus et autour du patient, tandis que la main droite s'enfonce sous le rebord costal gauche en direction de la rate. On peut également demander au patient d'**inspirer profondément**.

Les reins ne sont pas physiologiquement palpables. Il faut seulement poser une main à plat au niveau d'une loge rénale, puis taper dessus avec l'autre poing, et faire la même chose à l'autre loge. Cela ne devrait pas être douloureux.

Il faut également **palper l'aorte**, en appuyant fermement sur la partie supérieure de l'abdomen, légèrement à gauche de la ligne médiane. Plus difficile à palper chez les obèses.

Orifice herniaire

Il y a 4 orifices herniaires physiologiques, auxquels s'ajoutent un orifice cicatriciel si le patient a été opéré de l'appendicite: au niveau épigastrique, ombilical, inguinal et fémoral. Il faut mettre le doigt dans ces régions à la recherche de voussure, et demander au patient de lever la tête pour qu'il contracte sa musculature, voir si l'on sent quelque chose arriver contre son doigt.



ANNONCER QUE L'ON TERMINE L'EXAMEN PAR UN TOUCHER RECTAL.